

22 - 04-L'hémoptysie - Pr A. BENJELLOUN

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi ajma'in. Chers étudiants, dans la suite de nos cours sur la sémiologie respiratoire, nous allons voir un symptôme qui est assez fréquent, qui est heureusement moins fréquent que les autres, mais que vous pouvez avoir en cabinet de médecine générale ou de médecine spécialisée. Il s'agit de l'hémoptysie.

L'hémoptysie, vous le savez, c'est des expectorations de sang. C'est du sang qui sort lors d'un effort de tout. On va la définir.

Alors, quels sont les objectifs ? Définir d'abord une hémoptysie, décrire les mécanismes de cette hémoptysie, analyser l'hémoptysie de par son abondance, sa gravité, et les signes accompagnateurs, énumérer les principales étiologies des hémoptysies, et établir un algorithme simple de prise en charge de l'hémoptysie, comme on l'a fait pour la toux. Il y aura donc 4 chapitres, la définition, le mécanisme, l'analyse sémiologique et les étiologies. L'hémoptysie, comme je l'ai dit, c'est une expectoration de sang rouge, vif, aéré, spumeux, donc en forme d'écume, provenant des voies aériennes sous-glottiques, suite à une toux.

Tout ce qui est au-dessus de la glotte, ce n'est pas une hémoptysie. L'origine peut être triple, systémique, surtout systémique, à 90%. Donc si vous avez une hémoptysie, elle est surtout systémique.

On peut avoir des hémoptysies d'origine artérielle-pulmonaire, elles sont rares, ou bien des hémoptysies capillaire-pulmonaire, elles sont rares également. Quels sont les diagnostics différentiels ? Il est essentiel d'éliminer le diagnostic avant de commencer un bilan étiologique de l'hémoptysie. Il faut d'abord savoir si c'est une hémoptysie.

Il faut éliminer les mathémèses. Les mathémèses, c'est un rejet de sang d'origine digestive par la bouche. Ce sont des vomissements avec des débris alimentaires.

Donc bien demander aux patients, vous avez craché du sang, oui, mais est-ce que c'était suite à un effort de toux ou un effort de vomissement ? C'est essentiel pour voir si on va lui faire une fibroscopie digestive ou une endoscopie bronchique. Les épistaxies, méfiez-vous des épistaxies, c'est des saignements d'origine nasale que le patient peut faire sortir de la bouche. Ou bien des gingivoragies, des saignements pharyngé, laryngé, des saignements lingots.

Il faut bien faire un examen de la bouche, voir si le patient n'a pas un problème de gencives et de dents. Donc nous avons dit que l'hémoptysie avait une origine du cycle. Surtout la vascularisation systémique à 90%.

Il s'agit d'une circulation à haute pression. Elle provient surtout de l'artère bronchique. L'artère bronchique vascularise le poumon.

C'est une artère nourricière qui ne participe pas aux échanges. C'est l'artère qui vascularise les bronches et les poumons. Elle provient directement de l'aort.

C'est ces branches, les branches de l'artère bronchique qui vont saigner le plus souvent. Parfois, vous pouvez avoir des artères non bronchiques, sous clavère ou oesophagènes. Mais retenez, c'est surtout l'artère bronchique.

C'est elle qui est responsable des saignements des cancers bronchiques, des bronchectasies, des tuberculoses, des aspergillomes, etc. La plupart des hémoptysies en provenance de l'appareil respiratoire, c'est l'artère bronchique nourricière. Vous avez une vascularisation pulmonaire qui est à basse pression, mais à haut débit.

C'est surtout les malformations artériovéneuses qui vont saigner. Elles sont rares. Elles sont dans le cadre d'une maladie génétique qui s'appelle la maladie de Rendu-Osler.

Vous pouvez aussi avoir les tumeurs de l'artère pulmonaire. Elles sont exceptionnelles. Après, vous avez les saignements des capillaires pulmonaires.

Les capillaires pulmonaires, ils existent au niveau de la paroi alvéolaire. Les hémorragies, le saignement des capillaires pulmonaires, c'est ce qui définit les hémorragies alvéolaires. Ces hémorragies alvéolaires, on peut le voir dans plusieurs pathologies.

Parfois, elles sont médicamenteuses, mais on les voit surtout dans les vascularites auto-immunes, comme la maladie de Wegener, ou la polyangélite microscopique, parfois même la maladie de Churg-Strauss. Ce sont des vascularites, ce sont des maladies de système, des maladies auto-immunes qui peuvent donner des capillarites et donner une hémorragie alvéolaire parfois très grave. Mais vous pouvez avoir aussi un saignement des capillaires pulmonaires lors des insuffisances ventriculaires.

Quelles sont les circonstances de survenue ? On va faire de l'analyse sémiologique. L'hémoptysie peut survenir de façon inopinée, brutale. En général, c'est un signe révélateur d'une pathologie qu'on ne connaît pas encore chez le patient.

Ça peut être dans le cadre d'une maladie évolutive, un cancer bronchique qu'on connaît déjà, une tuberculose, vous pouvez avoir des hémoptysies massives, vous n'avez le temps de rien faire, vous regardez le patient mourir. Il faut rechercher les facteurs déclenchants ou favorisants. Ça peut être un effort musculaire, un bain chaud, une insolation.

Ça peut être l'ordre de menstruation ou un traumatisme thoracique. Il faut rechercher l'abondance. Une hémoptysie minime à faible doit être inférieure à 50 millilitres.

Entre 50 à 200 millilitres, on parle de moyenne abondance. Grave lorsque c'est supérieur à 200 millilitres en une fois ou à un demi-litre en 24 heures ou lorsqu'il y a un choc hémodynamique et

ou une détresse respiratoire aiguë. Elle est foudroyante, l'hémoptysie est foudroyante lorsqu'elle met en jeu le pronostic vital.

Là, vous avez une estimation de la quantité. Une cuillère à soupe pleine au 3 quarts représente environ 10 millilitres pour avoir une idée. Un verre ou un crachoir plein au 3 quarts représente environ 100 millilitres.

Un haricot ou un bol plein au 3 quarts représente un demi-litre. Il faut rechercher les prodromes. C'est quoi les prodromes? Ce sont les signes avant-coureurs.

Ce sont les signes qui peuvent précéder l'hémoptysie. On peut avoir un malaise un petit peu vague, une sensation de mal-être. On peut avoir une angoisse, une sensation d'oppression thoracique, un petit picotement laryngé qui est typique de la remontée du sang dans la gorge.

On peut avoir une chaleur rétrosternale, c'est la montée du sang dans la bronche, dans les bronches et dans la trachée. Vous pouvez avoir un goût métallique dans la bouche. Et vous pouvez avoir un épisode unique ou répétitif avec des crachats de plus en plus foncés les jours suivants.

C'est la queue de l'hémoptysie, c'est-à-dire que vous avez des crachats hémoptoïques, des hémoptysies et puis toutes les hémoptysies ne sont pas expectorées. Vous avez un certain nombre, vous avez une quantité de sang qui reste dans les bronches. Et cette quantité va coaguler et donc vous allez avoir du sang noir être que le patient va expectorer.

C'est la queue de l'hémoptysie, c'est la fin de l'hémoptysie. Il faut rechercher les signes associés, la pâleur, la sueur, l'attaque qui cache l'hypotension. Ce sont des signes de choc hémodynamique.

Et vous pouvez avoir des signes qui peuvent évoquer d'autres pathologies comme la dyspnée, la toux, la fièvre qui peuvent être évocatrices d'aspergillome, de tuberculose, de cancer bronchi. En fonction de la gravité, alors l'hémoptysie est dite grave si elle est supérieure à 200 ml par heure malgré une fonction respiratoire normale. Une hémoptysie de plus de 200 ml en une heure, même des poumons normaux, elle est très dangereuse.

Ou bien plus de 50 ml par heure en cas d'insuffisance respiratoire chronique. Un BPCO qui a très peu de, qui a une fonction respiratoire qui est abaissée, s'il saigne à l'intérieur des bronches, c'est plus grave que si un sujet sain saigne. Donc 50 ml pour un BPCO, pour un onfysémate grave, il est aussi grave que 200 ml pour un poumon normal.

Donc tout est relatif. Supérieur à deux épisodes modérés, malgré les vasoconstricteurs, c'est considéré comme une hémoptysie grave. Lorsque vous avez un choc hémodynamique, la baisse de la tension artérielle avec un bouffant, là il faut remplir, faire un remplissage par des macromolécules, l'LOS, le Ringer, etc.

Lorsque vous avez une anémie importante, c'est grave, il faut préparer des culots globulaires pour transfuser le patient. Le décès survient en général soit par spoliation sanguine, une perte importante de sang, ou alors par inondation de l'arbre trachéobronchique et des poumons, par l'hémoptysie, donc par détresse respiratoire. Quelles sont les causes les plus fréquentes des hémoptysies ? On a des centaines, on ne va pas toutes les énumérer.

Vous avez les causes respiratoires d'abord. En tête de liste, il faut mettre le cancer bronchique. Dans le contexte marocain, vous avez également la tuberculose.

Il y a les bronchectasies et surtout lors de surinfections. D'autres infections peuvent s'accompagner de hémoptysie. La bronchite aiguë, plus rarement.

La pneumopathie, surtout la pneumonie franche alvéolaire aiguë, la pneumocoque. Vous pouvez avoir des crachats hémoptoïques. La leptospirose qui donne un syndrome ichthéro-hémorragique.

Vous avez des saignements de partout. Vous pouvez aussi avoir des hémoptysies. L'aspergillome qui se greffe sur des séquelles tuberculeuses peut saigner.

L'aspergillose chronique ou subaiguë peut aussi saigner. Les mycobactérioses atypiques comme pour la tuberculose peuvent donner des hémoptysies. Vous pouvez avoir une tumeur bénigne bronchique.

Il ne faut pas hésiter à envoyer au pneumologue pour faire une fibroscopie. Certaines maladies de système donnent des hémoptysies. La sarcoïdose surtout lors des hémorragies alvéolaires.

Les vascularites et la mylose. Certaines pneumocognoses comme l'asbestose et la silicose. La bérillose peuvent donner des hémoptysies.

Et l'endométriose bronchopulmonaire elle est plutôt rare elle survient bien entendu chez la femme. Les causes cardiaques en tête de liste vous avez l'insuffisance cardiaque gauche ça donne surtout des expectorations rosées plus que rouges. Le rétrécissement mitral même en l'absence d'insuffisance cardiaque peut donner des hémoptysies et des cardiopathies congénitales.

Les causes vasculaires l'embolie pulmonaire surtout lorsqu'il y a un infarctus pulmonaire. Les ruptures d'anévrismes artériovéneux. L'hypertension pulmonaire primitive surtout au stade avancé peut donner des hémoptysies.

Un anévrisme de la thoracie groupée dans une branche peut donner une hémoptysie en général massive et en général il est déjà trop tard. Et une pathologie qui s'appelle la séquestration pulmonaire c'est un petit poumon dans le poumon qui est un petit peu indépendant, qui peut se surinfecter et qui peut donner des hémoptysies. Les troubles de l'hémostase peuvent également

donner des saignements lorsque vous avez un traitement anticoagulant ou une hémopathie qui donne des troubles de la coagulation.

L'hémoptysie peut être traumatique ou iatrogène de fracture costale avec contusion pulmonaire ou bien iatrogène par fibroscopie bronchique ou fonction biopsie pleurale. Un corps étranger intrabronchique également, parfois on ne retrouve rien du tout. Vous avez des hémoptysies idiopathiques et dans un certain nombre de cas dans 15% des cas, vous ne retrouvez aucune étiologie.

Vous aurez beau faire des scanners des fibroscopies, tout ce que vous voulez vous ne trouverez pas de cause. Il faut chercher de façon symptomatique et attendre. Là je vous montre un petit algorithme pour diagnostiquer les hémoptysies il y a des algorithmes beaucoup plus compliqués mais j'ai préféré simplifier les choses.

Alors si elle est une hémoptysie on va d'abord prendre les cas où elle est grave ou mal supportée. Il faut faire le plus tôt possible une fibroscopie bronchique une TDM thoracique et puis un traitement en urgence médicamenteux, embolisation éventuellement. Médicamenteux c'est les hémostatiques mais il faut aussi équilibrer l'état hémodynamique remplissage voir si le patient a besoin de culot globulaire et puis une réanimation respiratoire.

Si elle est minime ou modérée, là vous avez le temps de réfléchir. Vous faites un interrogatoire, un bon examen clinique et puis une radiographie thoracique. S'il y a une orientation diagnostic vous suivez votre orientation jusqu'au diagnostic.

Sinon si ça ne donne rien, vous faites une fibroscopie bronchique et un scanner thoracique. Avec la fibroscopie et le scanner en général vous arrivez à localiser l'hémoptysie et à faire un diagnostic étiologique et là il faut traiter soit un traitement médicamenteux lorsque l'hémoptysie n'est pas très abondante par la télépressine un hémostatique, soit par embolisation radiologique par artériographie soit, et c'est en dernier recours la chirurgie. Alors la chirurgie ne se fait pas en urgence.

Si vous envoyez quelqu'un qui fait une hémoptysie importante en chirurgie d'emblée il a 50% de chance de mourir. Donc la chirurgie en aigu, c'est en dernier recours. Par contre si vous trouvez une étiologie qui doit être opérée comme un cancer bronchique localisé comme un aspergillo il faut envisager une chirurgie thoracique.

Alors retenez que jamais de chirurgie en urgence dans une hémoptysie. Vous avez de grandes chances de perdre votre malade.